

TEMA 9.22 • RESPIRATORIO

Asma: Clínica y Diagnóstico

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **disfonía crónica** se define clásicamente como una alteración de la voz que persiste por **más de tres semanas**. Aunque algunos autores sugieren plazos de dos o cuatro semanas, el umbral de los 21 días es el más aceptado para iniciar un estudio formal. Si un paciente presenta una disfonía de dos semanas que empeora progresivamente, debe manejarse bajo la misma sospecha clínica.

El estudio fundamental ante toda disfonía crónica es la **nasofibrolaringoscopia (NFL)**. Este examen permite visualizar directamente la laringe, evaluar la movilidad de las cuerdas vocales e identificar lesiones estructurales para determinar el tratamiento específico.

1. Nódulos Vocales

Son lesiones benignas producto de un trauma fonatorio crónico. Es la causa más frecuente en personas que utilizan su voz profesionalmente o de forma inadecuada.

- **Clínica:** Antecedente de **abuso vocal** (profesores, cantantes, niños gritones, vendedores ambulantes). Presentan una voz ronca característica que empeora con el uso, pero que **no desaparece totalmente con el reposo** debido a la presencia física del nódulo.
- **Diagnóstico (NFL):** Se observan lesiones **bilaterales y simétricas**, habitualmente en la unión del tercio anterior con el tercio medio de las cuerdas vocales (punto de mayor contacto).
- **Tratamiento:** Es eminentemente funcional.
 - 1. Reposo vocal.
 - 2. Higiene vocal (evitar irritantes como el tabaco).
 - 3. **Rehabilitación fonoaudiológica:** Para mejorar la técnica de fonación y proyección de la voz.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencia clave EUNACOM: Los **Nódulos** son siempre **bilaterales** (por el choque de ambas cuerdas), mientras que los **Pólipos** suelen ser **unilaterales**.

2. Disfonía Músculo-Tensional

Es una patología funcional donde existe una excesiva tensión de la musculatura laríngea durante la fonación.

- **Clínica:** Similar a los nódulos (abuso vocal), pero con una diferencia fundamental: la disfonía **desaparece por completo con el reposo vocal** (el paciente amanece bien y termina el día disfónico).
- **Diagnóstico (NFL):** La laringe es **absolutamente normal**. No se observan lesiones estructurales.
- **Tratamiento:** Reeducación vocal y técnicas de relajación fonatoria.

3. Pólipos Vocales

A diferencia de los nódulos, los pólipos suelen tener un componente vascular o traumático agudo más marcado.

- **Clínica:** Puede aparecer tras un episodio de **esfuerzo vocal agudo** (un grito súbito, un concierto, un accidente) que genera una pequeña hemorragia submucosa. Se asocia fuertemente al tabaquismo y al **Reflujo Gastroesofágico**.
- **Diagnóstico (NFL):** Lesión pediculada o sésil, habitualmente **unilateral**.
- **Tratamiento:** Generalmente **quirúrgico**. Se realiza la exéresis de la lesión para estudio histopatológico (biopsia) y para recuperar la función vocal, sumado al manejo de factores irritantes.

TABLA 9.22.1: CARACTERÍSTICA VS NÓDULOS VOCALES

CARACTERÍSTICA	NÓDULOS VOCALES	PÓLIPOS VOCALES
Lateralidad	Bilaterales	Unilaterales
Causa principal	Abuso vocal crónico	Trauma agudo / Tabaco / Reflujo
Tratamiento	Fonoaudiología (Funcional)	Cirugía (Exéresis)
Reposo	Mejora parcialmente	No mejora la lesión

4. Edema de Reinke (Corditis Polipoidea)

Consiste en la acumulación de líquido gelatinoso en el espacio de Reinke (capa superficial de la lámina propia de la cuerda vocal).

- **Clínica:** Típico en **mujeres fumadoras**. Se describe una voz muy ronca, de tono muy bajo (voz "masculinizada").
- **Factores de riesgo:** Tabaquismo crónico (principal), abuso vocal, **Reflujo Gastroesofágico e Hipotiroidismo**.
- **Diagnóstico (NFL):** Cuerdas vocales de aspecto edematoso, "en bolsa", con aumento de volumen blando. Puede asociarse a **laringitis posterior** si hay reflujo.
- **Tratamiento:**
 - 1. Cese del hábito tabáquico.
 - 2. Manejo del reflujo o hipotiroidismo.
 - 3. Microcirugía laríngea (decorticación) en casos severos o que no responden al manejo médico.

5. Parálisis del Nervio Laríngeo Recurrente

El nervio laríngeo recurrente (rama del vago) tiene un trayecto largo: en el lado derecho rodea la arteria subclavia y en el izquierdo el arco aórtico, ascendiendo luego por el surco traqueoesofágico.

- **Etiología:**
 - - **Quirúrgica:** Cirugía de tiroides (causa más común), cirugía de tórax o cuello.
 - - **Neoplásica:** **Cáncer de Tiroides**, cáncer de pulmón (especialmente el de células pequeñas en el lado izquierdo), tumores de esófago o mediastino.
 - - **Cardiovascular (Síndrome de Ortner):** Compresión del nervio por una aurícula izquierda dilatada (**Estenosis Mitral**), aneurisma de aorta o hipertensión pulmonar.
- **Clínica:**
 - - **Unilateral:** Voz **bitonal** (dos tonos simultáneos) y de bajo volumen (soplo por escape de aire).
 - - **Bilateral:** **Disnea** y estridor inspiratorio (emergencia de vía aérea).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Una parálisis bilateral de cuerdas vocales suele dejar las cuerdas en posición medial, cerrando la glotis. Esto puede requerir intubación de urgencia o traqueostomía inmediata.

- **Diagnóstico:** NFL para ver la cuerda paralizada (habitualmente en posición paramedial). Se puede solicitar una **Electromiografía Laríngea** para determinar si la lesión es una neuropraxia (transitoria) o una sección completa (permanente).

NOTA CLÍNICA

Si un paciente presenta **dolor torácico súbito y disfonía aguda**, se debe sospechar una **Dissección Aórtica** que compromete el trayecto del nervio laríngeo recurrente izquierdo.

6. Cáncer de Laringe

Es una patología que debe sospecharse en todo paciente con factores de riesgo y disfonía persistente.

- **Clínica:** Paciente mayor, tabaquismo y alcoholismo crónico. Presenta una **voz leñosa o rasposa** que no mejora. Puede asociarse a disfagia, otalgia referida, baja de peso y adenopatías cervicales.
- **Diagnóstico:**
 - 1. **NFL:** Visualiza la lesión (exofítica, ulcerada o infiltrante).
 - 2. **Laringoscopia directa + Biopsia:** Es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo (realizado en pabellón).
 - 3. **Estadificación:** TAC de cuello y tórax para evaluar extensión local y a distancia.
- **Tratamiento:** Depende del estadio (Cirugía, Radioterapia y/o Quimioterapia). En tumores glóticos precoces, la radioterapia o microcirugía láser tienen excelentes resultados.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante una disfonía crónica en un fumador, la primera prioridad es descartar **Cáncer de Laringe** mediante nasofibrolaringoscopia.

- **Temas relacionados:**
- **Reflujo Gastroesofágico**
- **Cáncer de Laringe**
- **Hipotiroidismo**
- **Estenosis Mitral**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 25 años consulta por tos nocturna recurrente de 6 meses de evolución que empeora tras ejercicio y durante cuadros gripales. El examen físico está completamente normal y la radiografía de tórax no muestra alteraciones. Se solicita espirometría que resulta normal. ¿Cuál es el examen más apropiado a solicitar?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Asma: Clínica y Diagnóstico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El asma se debe a hiperreactividad bronquial con broncoconstricción e hipersecreción, frecuentemente mediada por IgE.
- La tos es el síntoma más frecuente; la clínica es recurrente y predomina en la noche, post-ejercicio y con infecciones virales.
- El examen físico y la radiografía de tórax frecuentemente están completamente normales.
- El diagnóstico del asma es fundamentalmente clínico.
- La espirometría es el examen más importante: muestra patrón obstructivo que mejora con broncodilatador en el paciente obstruido.
- En asma intermitente con espirometría normal, el examen de elección es el test de provocación con metacolina.
- La metacolina está contraindicada en pacientes ya obstruidos (riesgo de empeorar la obstrucción).
- Los riesgos del asma incluyen deterioro de calidad de vida, hospitalizaciones, evolución a EPOC y efectos adversos del tratamiento.
- El prick test y tests de alergias permiten identificar alérgenos específicos para evitarlos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ASMA: CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO)

PREGUNTA 1

Paciente de 25 años consulta por tos nocturna recurrente de 6 meses de evolución que empeora tras ejercicio y durante cuadros gripales. El examen físico está completamente normal y la radiografía de tórax no muestra alteraciones. Se solicita espirometría que resulta normal. ¿Cuál es el examen más apropiado a solicitar?

- A) TAC de tórax de alta resolución.
- B) Broncoscopia con lavado broncoalveolar.
- C) Test de provocación con metacolina.
- D) Repetir espirometría en 3 meses.
- E) Gasometría arterial.

PREGUNTA 2

Paciente de 18 años asmático conocido consulta por disnea y sibilancias audibles. Al examen se auscultan sibilancias bilaterales difusas. ¿Cuál examen es el más apropiado para objetivar su condición actual?

- A) Test de provocación con metacolina.
- B) Espirometría con prueba broncodilatadora.
- C) Prick test para identificar alérgenos.
- D) Radiografía de tórax.
- E) Hemograma con recuento de eosinófilos.

PREGUNTA 3

Respecto al asma bronquial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A) Los síntomas se desencadenan durante el ejercicio y mejoran al descansar.
- B) La radiografía de tórax siempre muestra hiperinsuflación en pacientes asmáticos.
- C) El patrón espirométrico muestra obstrucción que NO mejora con broncodilatador.
- D) La tos es el síntoma más frecuente y la clínica predomina en la noche.
- E) El diagnóstico requiere obligatoriamente confirmación con espirometría alterada.

RESUMEN: ASMA: CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

El asma bronquial se debe a hiperreactividad bronquial frecuentemente asociada a reacciones alérgicas mediadas por IgE, que produce broncoconstricción e hipersecreción. La clínica evoluciona en crisis recurrentes, siendo la tos el síntoma más frecuente, acompañada de disnea y clínica obstructiva que predomina en la noche (exposición a ácaros del polvo), post-ejercicio (al descansar, no durante) y durante infecciones virales. El examen físico puede mostrar aumento del diámetro anteroposterior del tórax, sibilancias, roncus, hipersonoridad y disminución del murmullo pulmonar, aunque frecuentemente es completamente normal, al igual que la radiografía de tórax. Los riesgos principales del asma incluyen deterioro de la calidad de vida, hospitalizaciones, evolución a daño pulmonar crónico tipo EPOC y complicaciones derivadas del tratamiento (taquicardia por beta-agonistas, efectos adversos de corticoides). El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero existen exámenes de apoyo para objetivarlo y hacer seguimiento. La espirometría es el examen más importante y se indica en el paciente obstruido, donde muestra un patrón obstructivo que mejora con broncodilatador. En el asma intermitente con espirometría normal, el examen de elección es el test de provocación con metacolina, que demuestra hiperreactividad bronquial al producir caída significativa de los parámetros espirométricos al estimular con un broncoconstrictor. La metacolina está contraindicada en pacientes ya obstruidos porque empeoraría la obstrucción. Otros exámenes complementarios incluyen el PEF (flujo espiratorio máximo), el prick test y otros tests de alergias para identificar alérgenos específicos evitables.